

TEMA 3.8 • OBSTETRICIA

Metrorragia de la Primera Mitad del Embarazo (< 20 semanas)

PERFIL EUNACOM 2.01.2.015

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Metrorragia de la Primera Mitad del Embarazo (< 20 semanas)

Causas (en orden de frecuencia)

- Aborto (más frecuente)
- Embarazo ectópico
- Enfermedad trofoblástica gestacional (mola)

Enfoque Diagnóstico

Paso 1: Especuloscopia

Descartar causas ginecológicas (sangrado del cuello, lesión vaginal). Si se confirma que la sangre viene del **orificio cervical externo** → causa uterina/intrauterina.

Paso 2: Ecografía transvaginal (ETV)

TABLA 3.8.1: HALLAZGO ETV VS DIAGNÓSTICO PROBABLE	
HALLAZGO ETV	DIAGNÓSTICO PROBABLE
Embarazo intrauterino	Aborto (amenaza o en curso)
Sin embarazo intrauterino	Embarazo ectópico
Tumor anexial con latidos fetales	Embarazo ectópico (confirma)
Imagen en "copos de nieve" / múltiples quistes	Mola hidatiforme (ETG)

NOTA CLÍNICA

Un tumor anexial sin latidos fetales NO diferencia entre aborto (cuerpo lúteo) y ectópico. Lo que hace la diferencia es la presencia o ausencia de embarazo intrauterino.

Manejo Resumido por Causa

TABLA 3.8.2: CAUSA VS MANEJO	
CAUSA	MANEJO
Amenaza de aborto	Conducta expectante, reposo, abstinencia sexual
Aborto inevitable / en evolución	Conducir trabajo de aborto
Embarazo ectópico roto	Cirugía urgente (laparoscopia o laparotomía)
Mola hidatiforme	Evacuación + seguimiento con β-HCG

Profilaxis Rh

En **todos los casos de aborto** (si la madre es Rh negativo) → administrar **ROGAM (gammaglobulina anti-D)** para evitar isoimmunización.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"En relación a Metrorragia de la Primera Mitad del Embarazo (< 20 semanas): Metrorragia de la Primera Mitad del Embarazo (< 20 semanas) ## Causas (en orden... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Metrorragia de la Primera Mitad del Embarazo (< 20 semanas). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Causas (en orden de frecuencia)
- Enfoque Diagnóstico
- Paso 1: Especuloscopia
- Paso 2: Ecografía transvaginal (ETV)
- Manejo Resumido por Causa
- Profilaxis Rh
- Enfermedad trofoblástica gestacional

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (METRORRAGIA DE LA PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO (< 20 SEMANAS))**PREGUNTA 1**

En relación a Metrorragia de la Primera Mitad del Embarazo (< 20 semanas): Metrorragia de la Primera Mitad del Embarazo (< 20 semanas) ## Causas (en orden... ¿cuál es la conducta correcta?

- A)** El diagnóstico de Metrorragia de la Primera Mitad del Embarazo (< 20 semanas) se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Metrorragia de la Primera Mitad del Embarazo (< 20 semanas) debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Metrorragia de la Primera Mitad del Embarazo (< 20 semanas) requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Metrorragia de la Primera Mitad del Embarazo (< 20 semanas) es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Metrorragia de la Primera Mitad del Embarazo (< 20 semanas) no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Metrorragia de la Primera Mitad del Embarazo (< 20 semanas)?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Metrorragia de la Primera Mitad del Embarazo (< 20 semanas). Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: METRORRAGIA DE LA PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO (< 20 SEMANAS)

Descartar causas ginecológicas (sangrado del cuello, lesión vaginal). Si se confirma que la sangre viene del orificio cervical externo → causa uterina/intrauterina. ::::note Un tumor anexial sin latidos fetales NO diferencia entre aborto (cuerpo lúteo) y ectópico. Lo que hace la diferencia es la presencia o ausencia de embarazo intrauterino. ::: En todos los casos de aborto (si la madre es Rh negativo) → administrar ROGAM (gammaglobulina anti-D) para evitar isoimmunización.